

Deterioro clínico, urgencia y primer respondiente

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Reconocer deterioro, suspender terapia y activar la atención urgente sin retrasos administrativos.

2. Alcance y condiciones de uso

Consultorio de terapias; no se convierte en servicio de urgencias. Reanimación, desfibrilación y otras acciones se realizan solo según entrenamiento, dotación y procedimiento vigente aplicable.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Antes de iniciar verificar síntomas y condiciones de riesgo

Antes de iniciar verificar síntomas y condiciones de riesgo. Establecer ruta real para apoyo urgente, dirección exacta, acceso y contacto del sistema de emergencias del territorio.

2. Ante pérdida de conciencia, dolor torácico, disnea grave, convulsión, déficit neurológico

Ante pérdida de conciencia, dolor torácico, disnea grave, convulsión, déficit neurológico súbito, reacción importante o hemorragia, interrumpir técnica y proteger del peligro sin aplicar maniobras no competentes.

3. Evaluar respuesta y respiración dentro de formación

Evaluar respuesta y respiración dentro de formación. Activar ayuda y solicitar recurso adecuado, dar dirección y situación, seguir instrucciones y no dejar solo al paciente.

4. Realizar primeros auxilios y soporte que el entrenamiento permite

Realizar primeros auxilios y soporte que el entrenamiento permite. Si la persona no responde y no respira normalmente, activar respuesta de paro y aplicar el protocolo de soporte vital vigente y DEA si disponible y capacitado.

5. Preparar resumen de hechos, antecedentes conocidos, tiempos, intervenciones y respuesta

Preparar resumen de hechos, antecedentes conocidos, tiempos, intervenciones y respuesta. No enviar a una persona clínicamente inestable sola por taxi ni esperar una autorización de pago.

6. Registrar quién recibe, hora, medio, comunicación y continuidad

Registrar quién recibe, hora, medio, comunicación y continuidad. Analizar el evento y reponer recursos usados; formar al equipo y revisar tiempos de activación.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Directorio y acceso probados.

Atención prioritaria a la condición clínica.

Protocolo de soporte vital requiere formación vigente, no sustitución por texto.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente y fecha hora	
Síntomas iniciales	
Intervención suspendida	
Evaluación y tiempos	
Llamado y respuesta	
Soporte realizado	
Destino y medio	
Resumen enviado	
Persona receptora	
Seguimiento	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576